DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: MANUEL HELMAN CARVAJAL OSORIO **Identificación** CC 79125718
Edad: 62 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S CONTRIBUTIVO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 10/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	ANK	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: C188 LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL COLON
Dx Postoperatorio: K573 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO GRUESO SIN PERFORACION NI ABSCESO

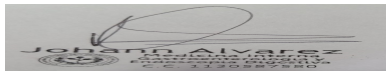
Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 10/11/26 **Fecha Final** 10/11/26
Hora Inicio 11:40:00 **Hora Final** 11:55:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****COLONOSCOPIA****
***INDICACIÓN: Lesion de colon ascendente
INSPECCIÓN: Normal
TACTO RECTAL: Normal
COLONOSCOPIA: Explorado hasta región cecal (identificando orificio apendicular y válvula ileocecal) Observando múltiples orificios diverticulares sin sangrado, sin edema. En colon ascendente proximal se observó lesión friable que compromete el 100% de la circunferencia y genera estenosis de 60 % y permite franquear a proximal de la cual se toman múltiples biopsias (12 Fg). En colon transverso proximal se observaron #2 pólipos sésiles menores a 7 mm. Canal anal paquete hemorroidal. Procedimiento sin complicaciones aparentes. Preparación Boston CD: 2, CT: 3, CI: 3 8/9.
BIOPSIA: FRASCO 1: Lesión de colon ascendente proximal
***CONCLUSIÓN:
1. DIVERTICULOSIS PANCOLONICA
2. LESIÓN DE COLON ASCENDENTE PROXIMAL: NEO
3. PÓLIPOS #2 PARIS 0-Is COLON TRANSVERSO PROXIMAL NO RESECADOS
4. HEMORROIDES GRADO II/IV
***Observaciones
Al ingreso a la sala se evidencia reaccion alergica torax anterior, dorso, gluteos y piernas (previo a inicio de procedimiento o de paso de algún medicamento).

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐
FRASCO 1: LESIÓN DE COLON ASCENDENTE PROXIMAL

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***